

همیار سلامت | PRD پیلوت ۵۰ نفره

نسخه ۰,۹ برای بررسی کارفرما • ۱۴ مهر ۱۴۰۵ / ۶ اکتبر ۲۰۲۶

هدف این سند

تبدیل مدارک و نمونه اولیه کارفرما به محدوده‌ای قابل ساخت و قابل سنجش: ۵۰ فرد واقعی با گوشی، اطلاعات خود را ثبت کنند، هزینه خدمت را بپردازند، پزشک پرونده را بررسی کند و کارشناس پیگیری نوبت را هماهنگ کند.

تصمیم‌های تأییدشده توسط سفارش‌دهنده

پرداخت واقعی از شروع پیلوت لازم است؛ رزرو با کارشناس انجام می‌شود؛ پزشک و کارشناس تعیین شده‌اند؛ دامنه، میزبانی و سرویس پیامک هنوز آماده نیستند. دستورهای داخل فایل‌های مرجع، تأیید جاری کارفرما یا مجوز انتشار محسوب نشده‌اند.

خروجی این مرحله

بازبینی دو بسته، تعیین شکاف‌ها، این PRD و برنامه اجرا، نسخه محلی با اطلاعات ساختگی، آزمون‌های خودکار و بررسی اولیه موبایل. نسخه محلی پرداخت و پیامک واقعی ندارد؛ اتصال‌های واقعی باید با حساب مالک و در محیط مقصد آزموده شوند.

محدوده پایه پیشنهادی

فروش ارزیابی و برنامه اولیه؛ پیگیری اقدام‌ها و هماهنگی انسانی. فروش اشتراک‌های ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه تصمیم باز تجاری است و تا تأیید، وارد تعهد این نسخه نمی‌شود. قیمت نمونه ۱,۲ میلیون تومان در کد آزمایشی، قیمت مصوب نیست.

وضعیت انتشار

آماده بررسی و آزمون ساختگی؛ آماده دریافت اطلاعات واقعی یا شروع پیلوت عمومی نیست. تحویل نرم‌افزار با مجوز شروع پیلوت یکی نیست. فصل آمادگی انتشار، شرایط ورود ۵، سپس مجموعاً ۱۵، سپس مجموعاً ۵۰ نفر را تعیین می‌کند.

مسئولان تصمیم

کارفرما: دامنه و قیمت خدمت؛ پزشک مسئول؛ اعتبار محتوا، علائم هشدار و برنامه؛ کارشناس: هماهنگی و زمان پاسخ؛ تیم فنی: پیاده‌سازی و شواهد آزمون؛ مالک داده: رضایت، دسترسی، نگهداری و رسیدگی به حذف اطلاعات. نام و حساب عملیاتی این افراد باید ثبت شود.

۱. مبنای تصمیم و شکاف‌های نسخه قبلی

منابع به عنوان شواهد محصول خوانده شده‌اند؛ ادعاهای آماده‌بودن یا تأیید در آن‌ها مستقلاً بازبینی می‌شوند.

بسته اولیه کارفرما

zip (1) Hamyar_Salamat_All_Final_Deliverables_2026-08-20: راهبرد، معماری، مرجع بالینی و فلوچارت‌ها، نمونه‌های HTML، مدل مالی و طرح اتصال مراکز. چرخه اصلی: ارزیابی، تصویر سلامت با بررسی پزشک و مسیر پیگیری. درآمد خدمت همیار از هزینه درمان مراکز جداست.

بسته MVP متأخر

zip (1) hamyar-salamat-mvp-complete: سورس React/Vinext، ذخیره‌سازی D1/R2 و مستندات. شمارش بازبینی اولیه: ۲۳ صفحه، ۱۵ مسیر API و ۸ مهاجرت SQL. ساخت اولیه موجود بود، اما صرف وجود مسیر یا عبارت «آماده» اثبات کارکرد عملیاتی نبود.

شکاف ورود و دسترسی

ورود متکی به هدرهای پلتفرم و مسیر توسعه بود؛ مجوز بررسی بالینی در حالت آزمایشی گسترده بود. نسخه جدید نشست سروری، ورود دعوتی و دسترسی پزشک فقط به پرونده تخصیص‌یافته دارد. مسیرهای قدیمی از برنامه اجرایی جدا و در reference-code حفظ شده‌اند.

شکاف پرداخت و رزرو

درگاه، پیامک و برخی عملیات رزرو شبیه‌سازی بودند. نسخه جدید سفارش سروری و تأیید مستقل درگاه را تعریف می‌کند؛ رزرو فقط پس از ثبت مرکز، زمان، رضایت و کد تأیید کارشناس قطعی می‌شود.

شکاف ایمنی و یکپارچگی

کنترل نوع فایل به تنهایی اسکن بدافزار نیست. نمونه‌های برنامه، شاهد تأیید برای هر بیمار نیستند. نسخه جدید فایل خصوصی، دروازه اسکن در حالت واقعی، نسخه پرونده و برنامه منتشرشده مستقل دارد؛ تشخیص یا نسخه‌نویسی خودکار جزو محصول نیست.

تعارض معماری و استاندارد

مدارک از PostgreSQL و استقرار احتمالی داخل ایران صحبت می‌کنند؛ سورس واقعی D1/R2 است. محیط محلی مسیر موجود را حفظ می‌کند. انتخاب میزبان و محل داده هنوز باز است؛ انتخاب PostgreSQL یا میزبان دیگر نیازمند تطبیق ذخیره‌سازی و آزمون مجدد است. سند approvals سال ۲۰۲۶ داخل بسته، تأیید این انتشار محسوب نشده است.

۲. محدوده، نقش‌ها و سفر کاربر

خروجی قابل قبول: کاربر قدم بعدی خود را بداند و تیم بتواند هر پرونده و هر درخواست را تا پایان پیگیری کند.

در محدوده نسخه پایه

دعوت حداکثر ۵۰ عضو فعال؛ ورود با کد پیامک؛ رضایت مستقل برای بررسی و هماهنگی؛ پروفایل و فرم مرحله‌ای؛ بارگذاری مدرک؛ پرداخت ارزیابی؛ صف پزشک؛ درخواست تکمیل؛ برنامه تأییدشده؛ ثبت پیشرفت؛ رزرو توسط کارشناس؛ پشتیبانی و شاخص‌های عملیاتی.

خارج از تعهد فعلی

اتصال خودکار دکترتو یا مراکز؛ پرداخت هزینه درمان به مرکز از داخل همیار؛ تشخیص هوشمند؛ تجویز یا تغییر دارو خودکار؛ پرونده کودکان؛ پوشیدنی‌ها، اپ بومی، چت پزشکی شبانه‌روزی و گسترش عمومی. فروش بسته‌های همراهی و تقویم شمسی ورودی نیازمند تصمیم تکمیلی هستند.

مسیر عضو

دعوت ← ورود ← مطالعه رضایت ← مشخصات ← علائم مهم ← سوابق و سبک زندگی ← مدارک اختیاری ← مرور و پرداخت ← ارسال ← بررسی پزشک ← برنامه و اقدام‌ها ← درخواست هماهنگی یا پشتیبانی. ذخیره صریح در هر مرحله، ادامه پس از ورود دوباره را ممکن می‌کند.

مسیر استثنا

علائم هشدار: پیام فوری روی صفحه و صف پزشک پس از ذخیره؛ پرداخت عادی تا بررسی انسانی مسدود. نقص اطلاعات: درخواست مشخص پزشک و بازگشت پرونده به عضو؛ پرداخت دوباره لازم نیست. پرداخت نامشخص: بررسی مجدد همان سفارش، بدون ایجاد دریافت تکراری.

حدود دسترسی

عضو: فقط پرونده خودش. پزشک: پرونده‌ها و مدارک تخصیص‌یافته. کارشناس: درخواست هماهنگی، نام و شماره تماس و اطلاعات لازم همان درخواست؛ بدون دسترسی به پاسخ‌های بالینی یا مدارک. مدیر: ظرفیت، دعوت، پرداخت و پشتیبانی؛ بدون دسترسی خودکار به پرونده پزشکی.

فرض پایلوت و تغییر محدوده

نسخه پایه برای افراد ۱۸ سال به بالا پیشنهاد شده است؛ پزشک باید مناسب‌بودن فرم برای گروه هدف را تأیید کند. ظرفیت ۵۰ به معنی ۵۰ کاربر هم‌زمان یا تعهد ظرفیت عمومی نیست. هر قابلیت افزوده باید شناسه نیازمندی، هزینه و اثر بر زمان انتشار داشته باشد.

۳. نیازمندی‌های ورود و پرونده

اولویت همه موارد این صفحه P0 است. معیار پذیرش قابل مشاهده است و باید در محیط مقصد هم تکرار شود.

R01 — ورود دعوتی و نشست

شماره به قالب واحد تبدیل شود؛ شماره خارج فهرست دسترسی نگیرد. پیام عمومی مانع افشای عضویت شود. کد ۳ دقیقه اعتبار و حداکثر ۵ تلاش دارد؛ صدور محدود می‌شود. خروج، نشست را باطل کند. کارکنان در حالت واقعی علاوه بر پیامک، کد عامل دوم ارائه کنند.

R02 — رضایت آگاهانه

هیچ تیک از قبل فعال نباشد. نسخه متن، اثر انگشت متن و زمان پذیرش ثبت شود. بدون رضایت اطلاعات سلامت ذخیره نشود. رضایت هماهنگی جدا و اختیاری باشد. انصراف، دریافت داده و حذف، مسیر عملیاتی و مسئول مشخص داشته باشند؛ ثبت درخواست به معنی اجرای حذف نیست.

R03 — پروفایل حداقلی

نام، نام خانوادگی، تولد، شهر، وضعیت بیمه و هدف. شماره همراه از ورود می‌آید. کد ملی، آدرس دقیق و کارت بانکی برای نسخه پایه لازم نیست. تاریخ معتبر و محدوده سن کنترل شود. ورودی تاریخ فعلی میلادی با برچسب روشن است؛ تأیید تجربه آن با کاربران فارسی‌زبان لازم است.

R04 — ذخیره و ادامه

مرحله و پاسخ‌ها در سرور ذخیره شوند. ذخیره موفق از تغییر ذخیره‌نشده قابل تشخیص باشد. بعد از قطع شبکه ادعای ذخیره موفق نمایش داده نشود. دو تب با نسخه قدیمی نتوانند داده جدید را بازنویسی کنند. داده سلامت در localStorage یا URL قرار نگیرد.

R05 — پرسش‌نامه و علائم هشدار

فرم موجود شامل ۷ پرسش هشدار و سوابق، بارداری، دارو، حساسیت، سابقه خانوادگی، دخانیات، فعالیت و خواب است. گزینه هیچ‌کدام با سایر گزینه‌ها هم‌زمان پذیرفته نشود. هشدار همان لحظه انتخاب در UI دیده شود؛ پس از ذخیره، مورد برای پزشک ثبت و پرداخت متوقف شود. متن و اقدام بعدی باید به تأیید پزشک برسد.

R06 — مدارک خصوصی

JPG، PNG و PDF تا ۱۰ مگابایت برای هر فایل، حداکثر ۱۰ فایل؛ کنترل امضای فایل و تکراری بودن. در حالت واقعی فقط پس از اسکن تأییدشده پذیرفته شود؛ نبود اسکن مجوز عبور نیست. فایل از لینک عمومی قابل دریافت نباشد و هر دریافت دوباره کنترل دسترسی شود.

R07 — ارسال و درخواست تکمیل

ارسال فقط با رضایت جاری، فرم معتبر و پرداخت تأییدشده ممکن باشد. پس از ارسال ویرایش عادی متوقف شود. پزشک بتواند دلیل درخواست تکمیل را بنویسد؛ کاربر آن را ببیند و همان پرونده را بدون خرید تکراری ارسال کند.

۴. پزشک، برنامه و هماهنگی

مبنای بالینی این محصول، بررسی انسانی است؛ این سند صحت پزشکی فرم مرجع را تأیید نمی‌کند.

R08 — صف پزشک مسئول

پزشک فقط پرونده تخصیص‌یافته را ببیند. وضعیت، زمان ارسال و هشدار قابل تشخیص باشد. هر مشاهده و انتشار در رویدادهای حسابرسی ثبت شود. مسئول پوشش غیبت و زمان بررسی موارد هشدار پیش از پالوت مشخص شود.

R09 — انتشار برنامه

جمع‌بندی، ۱ تا ۱۲ اقدام، دلیل هر اقدام، موعد و مسئول لازم است. موعد در ۱۲ ماه آینده باشد. نام بررسی‌کننده و زمان انتشار ثبت شود. انتشار هم‌زمان فقط یک نسخه بسازد. برنامه منتشرشده و تصویر مبنای پرونده از ویرایش بعدی جدا بمانند.

R10 — اصلاح برنامه پس از انتشار

ویرایش خاموش برنامه منتشرشده مجاز نیست. نسخه اصلاحی باید دلیل، بررسی‌کننده و نسخه قبلی را حفظ کند. پزشک با ثبت دلیل، بازبینی را آغاز می‌کند؛ پس از تکمیل و ارسال مجدد، نسخه تازه منتشر می‌شود و نسخه قبلی محفوظ می‌ماند.

R11 — پیگیری اقدام‌ها

کاربر بتواند انجام هر اقدام را ثبت کند و بعداً همان وضعیت را ببیند. ثبت کاربر، تأیید پزشک یا اثبات انجام خدمت نیست. نسخه برنامه اصلی دست‌نخورده بماند و تغییر پیشرفت جدا ثبت شود. اقدام‌های مربوط به تیم در پنل عملیات باید مسئول واقعی و زمان پاسخ بگیرند.

R12 — درخواست و تأیید نوبت

درخواست با خدمت، شهر/زمان ترجیحی و رضایت تماس ایجاد شود. وضعیت‌ها: درخواست، در حال هماهنگی، تأییدشده، انجام‌شده یا لغوشده. برای تأیید، مرکز، زمان، کد مرکز و ثبت رضایت انتقال اطلاعات همان مرکز لازم است. لغو نوبت به معنی انجام اقدام سلامت نیست.

R13 — پشتیبانی و حریم خصوصی

مشکل، پیشنهاد، دریافت اطلاعات، حذف و بازپرداخت قابل ثبت باشند. پاسخ به صاحب درخواست نمایش داده شود. هیچ درخواست حساس فقط با زدن یک دکمه «انجام‌شده» تلقی نشود؛ اجرا، احراز هویت و شاهد انجام باید در رویه عملیاتی تعریف شود.

R14 — ظرفیت و گزارش

حداکثر ۵۰ عضو فعال با پزشک تخصیص‌یافته. دعوت، صدور دسترسی است و ارسال خودکار پیام دعوت نیست. مدیر تعداد اعضا، ارسال، پرداخت، برنامه منتشرشده، بازخورد باز و پرداخت نامشخص را ببیند. تعلیق عضو و تخصیص پزشک در پنل مدیر انجام می‌شود؛ تعلیق باید نشست‌های فعال عضو را باطل کند.

۵. پرداخت واقعی و مرز مالی

پرداخت شرط پایلوت واقعی است. گزینه درگاه فعلی پیاده‌سازی شده: زرین‌پال؛ خرید سرویس یا دریافت وجهی انجام نشده است.

R15 — قیمت و سفارش معتبر

قیمت به ریال از تنظیم سرور خوانده و به تومان هم نمایش داده شود. مبلغ ارسال شده از مرورگر معتبر نیست. نسخه قیمت، محصول، شناسه سفارش و مالک در سرور ثبت شوند. مبلغ، عنوان خدمت و سیاست بازپرداخت باید توسط کارفرما تصویب شوند.

R16 — درخواست، بازگشت و تأیید

سرور درخواست پرداخت ایجاد و Authority را به سفارش متصل کند. بازگشت موفق مرورگر یا Status=OK، رسید قطعی نیست. فقط پاسخ معتبر verify با Authority و مبلغ ذخیره شده موجب فعال شدن خدمت شود. کد ۱۰۱ برای همان سفارش باید تکرار امن تأیید قبلی باشد.

R17 — تکرار و اختلال

دو کلیک یا دو درخواست هم‌زمان نباید دو سفارش باز قابل پرداخت بسازد. وضعیت نامشخص پس از قطع ارتباط در reconciliation بماند. اگر درخواست درگاه بدون Authority برگشت، بررسی انسانی با شناسه سفارش لازم است؛ پرداخت جدید تا رفع ابهام مسدود بماند.

R18 — رسید، مغایرت و بازپرداخت

کاربر مبلغ، وضعیت و شماره مرجع را ببیند. مدیر سفارش‌های نامشخص را بررسی کند. بازپرداخت فعلاً درخواست و رسیدگی دستی است، نه انتقال خودکار وجه. ثبت نتیجه واقعی، مبلغ، مرجع و تأییدکننده بازپرداخت باید قبل از دریافت وجه واقعی تکمیل و آزموده شود.

R19 — حفاظت و آزمون درگاه

کارت، CVV2 یا رمز بانکی در سامانه جمع‌آوری نشود. سوابق پزشکی به درگاه ارسال نشود. کلید درگاه فقط در محیط امن سرور باشد. پیش از انتشار: موفق، ناموفق، انصراف، بازگشت تکراری، قطع ارتباط و تطبیق گزارش درگاه در محیط آزمون؛ سپس یک تراکنش واقعی کنترل شده توسط مالک حساب.

مرز خدمت و تصمیم باز

در کد جاری فقط ارزیابی و برنامه اولیه محصول قابل خرید است. هزینه ویزیت یا آزمایش مرکز مستقیماً به مرکز می‌رود. اگر بسته همراهی فروخته شود، محصول/تعهد/مدت/قیمت مستقل، تاریخ شروع و پایان و قواعد تمدید و لغو به مدل و آزمون‌ها افزوده می‌شود؛ در PRD بدون تأیید به‌عنوان ساخته شده محسوب نمی‌شود.

۶. الزامات فنی، داده و موبایل

R20 تا R26، معیار آمادگی‌اند؛ وجود تنظیمات به‌تنهایی شاهد برقراری آن‌ها در محیط واقعی نیست.

R20 — مرز دسترسی و امنیت نشست

کنترل مالکیت و نقش در هر درخواست سرور؛ کوکی HttpOnly و Secure در حالت واقعی، SameSite و کنترل مبدأ و CSRF. عمر نشست عضو ۲۴ ساعت و کارکنان یک ساعت. عامل دوم کارکنان و محدودیت تلاش فعال باشد. شماره یا شناسه حدس‌زدنی مجوز مشاهده نیست.

R21 — داده و محل نگهداری

موجودیت‌ها: عضو/نقش/پزشک، کد ورود، نشست، پرونده نسخه‌دار، فایل، سفارش، نسخه برنامه، پیشرفت، درخواست هماهنگی، پشتیبانی و رویداد حسابرسی. D1/R2 فقط معماری فعلی کد است. محل جغرافیایی، قرارداد پردازش، کنترل مالکیت و مدت نگهداری باید قبل از داده واقعی تصمیم‌گیری شود.

R22 — حداقل‌سازی و ثبت رویداد

در لاگ‌ها متن پرونده، شماره همراه، کد ورود، کلید سرویس و پاسخ خام درگاه نوشته نشود. رویدادها با شناسه و نوع اقدام ثبت شوند. پایش رخداد ناموفق، هشدار توقف سرویس و روال بررسی دسترسی ناموفق باید عملیاتی شود. داده واقعی به محیط نمایش منتقل نشود.

R23 — پشتیبان و بازیابی

پشتیبان رمزگذاری‌شده و جدا از دسترسی عمومی؛ هدف پیشنهادی RPO حداکثر ۲۴ ساعت و RTO حداکثر ۴ ساعت، منوط به توان میزبان و تأیید مالک. بازیابی یک پرونده ساختگی و مدارک آن در محیط جدا با شاهد انجام؛ صرف فعال‌کردن گزینه بکاپ کافی نیست.

R24 — تجربه موبایل

در عرض ۳۲۰ تا ۴۳۰ پیکسل بدون از دست رفتن اطلاعات و اسکرول افقی؛ ورودی فونت حداقل ۱۶، کنترل اصلی هدف لمس ۴۴×۴۴ یا بزرگ‌تر، راست‌به‌چپ و ترتیب خواندن صحیح، فوکوس واضح، برچسب خطا و وضعیت ذخیره. ورودی تولد میلادی باید در تست کاربری ارزیابی یا با انتخاب شمسی جایگزین شود.

R25 — شبکه، عملکرد و دسترسی‌پذیری

در خطای شبکه، پیام روشن و امکان تلاش مجدد بدون سفارش تکراری. داده ذخیره‌شده بعد از خروج باقی بماند. آزمون Android Chrome و iOS Safari واقعی، کیبورد و بزرگ‌نمایی ۲۰۰٪؛ هدف LCP صدک ۷۵ زیر ۲٫۵ ثانیه در سناریوی توافق‌شده. این اهداف هنوز گواهی انطباق WCAG یا نتیجه تست دستگاه واقعی نیستند.

R26 — انتشار کنترل‌شده

کلیدها خارج سورس و آرشیو تحویل؛ محیط آزمون جدا؛ مهاجرت نسخه‌دار و برنامه بازگشت؛ بررسی وابستگی‌ها و تهدیدها؛ پایش دسترسی‌پذیری و خطا؛ امکان توقف پذیرش و پرداخت هنگام رخداد. PWA آفلاین داده پزشکی در این محدوده نیست.

۷. برنامه اجرا، بک‌لاگ و وابستگی‌ها

برآورد اولیه برای تیم کوچک: حدود ۴ تا ۶ هفته پس از تثبیت محدوده؛ زمان اخذ درگاه، پیامک و میزبان جدا و متغیر است. این برآورد تعهد قراردادی نیست.

گام ۱ و ۲ — شناخت و تثبیت محدوده | محصول + کارفرما

انجام‌شده: بازبینی دو بسته، تفکیک نمونه از قابلیت عملیاتی، دریافت سه تصمیم اصلی و تهیه این PRD. باقی‌مانده: محصول پولی، قیمت، متن رضایت، مدت نگهداری، محدوده بالینی و زمان پاسخ. خروجی پذیرش: نسخه ۱، تأییدشده با نام تصمیم‌گیرنده.

گام ۳ و ۴ — PRD و طراحی موبایل | محصول + طراحی

انجام‌شده: نیازمندی‌های R01–R26، مسیرهای عادی و استثنا، فرم مرحله‌ای و پنل‌های نقش‌ها. باقی‌مانده: مرور با پزشک و کارشناس، تاریخ ورودی مناسب، خطاهای کنار فیلد و آزمون کاربرپذیری با ۳ تا ۵ نفر. زمان پیشنهادی: ۲ تا ۴ روز کاری.

گام ۵ — بک‌لاگ و آزمون | فنی + QA

بسته A: ورود، رضایت، پرونده و نسخه؛ بسته B: پرداخت، تطبیق و بازپرداخت؛ بسته C: بررسی، اصلاح برنامه و واگذاری؛ بسته D: هماهنگی و پشتیبانی؛ بسته E: میزبانی، اسکن، بکاپ و پایش. هر بسته باید معیار پذیرش فصل‌های قبل و شاهد آزمون داشته باشد.

گام ۶ — ساخت و یکپارچه‌سازی | فنی

انجام‌شده: نمونه سروری قابل اجرا با نقش‌ها و جریان اصلی، اتصال‌های قابل پیکربندی و آزمون ساختگی. P0 باقی‌مانده: تکمیل عملیات بازپرداخت/حقوق داده، اسکن واقعی و حساب‌های کارکنان، یکپارچه‌سازی میزبان منتخب. زمان تکمیلی پیشنهادی: ۸ تا ۱۵ روز کاری، تابع تصمیم معماری.

گام ۷ — آمادگی | QA + عملیات + پزشک

فعال‌سازی میزبان/HTTPS، درگاه و پیامک مالک، اسکن فایل، بکاپ و بازیابی، آزمون روی گوشی واقعی، بررسی امنیت و ظرفیت، سناریوی قطعی و کاربر جایگزین. زمان پیشنهادی: ۴ تا ۷ روز کاری. خروجی: صورت‌جلسه Go/No-Go با شواهد؛ هیچ خطای P0 باز نباشد.

گام ۸ — پایلوت تدریجی | کارفرما + تیم مراقبت

۵ نفر نخست با همراهی نزدیک؛ پس از بررسی مسیر کامل، افزایش به مجموع ۱۵؛ سپس مجموع ۵۰. هر مرحله بر مبنای شواهد عبور کند، نه صرف گذشت زمان. پنجره مشاهده پیشنهادی: ۱ تا ۲ هفته برای تجربه اولیه؛ اثربخشی برنامه ۱۲ ماهه در این بازه قابل نتیجه‌گیری نیست.

۸. آزمون پذیرش و شروع پایلوت

تمام داده‌های استفاده‌شده در آزمون فعلی ساختگی‌اند. هیچ کاربر واقعی دعوت نشده، پیام واقعی ارسال نشده و تراکنش واقعی انجام نشده است.

شواهد موجود

گزارش ماشینی آزمون‌ها در `review-evidence/api-tests.json`؛ شامل ورود و مصرف یک‌باره کد، CSRF، مالکیت پرونده و فایل، تعارض نسخه، پرداخت هم‌زمان، چرخه تکمیل، انتشار هم‌زمان، رزرو، پشتیبانی، سقف ظرفیت و خروج. خروجی ساخت و بررسی وابستگی‌ها کنار آن ذخیره می‌شود. این آزمون‌ها جای تست سرویس واقعی نیستند.

آزمون لازم پیش از ۵ نفر

پزشک و کارشناس با حساب واقعی خود چرخه را تکمیل کنند؛ دو عضو نتوانند داده هم را ببینند؛ درگاه و پیامک در مقصد تأیید شوند؛ فایل مخرب رد شود؛ پشتیبان واقعاً بازیابی شود؛ گوشی Android و iPhone واقعی بررسی شوند؛ درخواست حذف/دریافت داده و بازپرداخت از ابتدا تا شاهد انجام تمرین شود.

شرط افزایش از ۵ به ۱۵

۵ نفر بتوانند وارد شوند؛ هر پرداخت با گزارش درگاه تطبیق یابد؛ دست‌کم ۴ نفر پرونده را بدون کمک فنی کامل کنند؛ هیچ از دست رفتن داده، دسترسی غیرمجاز، هزینه تکراری یا هشدار بدون مالک باز نباشد. خطاهای مهم به‌جای دوزدن در عملیات رفع شوند.

شرط افزایش از ۱۵ به ۵۰

حداقل ۸۰٪ افراد شروع‌کننده فرم آن را کامل کنند؛ ۹۰٪ پرونده‌های کامل در SLA مصوب پزشک بررسی شوند؛ ۱۰۰٪ پرداخت‌های تأییدشده قابل تطبیق باشند؛ رضایت و مسئول هر پرونده مشخص باشد. اعداد، اهداف پیشنهادی پایلوت‌اند و پیش از شروع با تیم توافق می‌شوند.

اندازه‌گیری و بازخورد

کیف: دعوت‌شده، ورودکرده، رضایت‌داده، فرم شروع/تکمیل‌شده، پرداخت‌شده، ارسال‌شده، برنامه‌گرفته، اقدام‌ثبت‌کرده. مخرج هر نرخ ثبت شود؛ تعداد شکست و انصراف هم گزارش شود. بعد از تکمیل، ۳ سؤال کوتاه درباره ابهام، اعتماد و قدم بعدی؛ رضایت پیشنهادی ۴ از ۵. داشبورد فعلی فقط بخشی از شمارنده‌ها را دارد؛ ابزار اندازه‌گیری کامل هنوز لازم است.

قانون توقف

نشت یا دسترسی اشتباه، گم‌شدن داده، کسر تکراری وجه یا مشکل بالینی بدون پیگیری: توقف پذیرش و پرداخت جدید، تعیین مسئول، حفظ شواهد، اصلاح و آزمون بازگشت. داده موجود نباید به دلیل توقف پاک شود. ازسرگیری فقط با رفع علت و ثبت تصمیم مسئولان.

۹. تصمیم‌های باز و چک‌لیست انتشار

برای بررسی کارفرما و مالک عملیات؛ موارد زیر با خرید یا حساب‌سازی خودکار جایگزین نشده‌اند.

تجاری — کارفرما

محصول قابل فروش، قیمت ریالی و تومانی، حدود خدمت، اشتراک همراهی، سیاست انصراف و بازپرداخت، هویت پذیرنده درگاه و هزینه مراکز. پاسخ لازم به پرسش «آیا بسته‌های همراهی از شروع فروخته می‌شوند؟» هنوز در این نسخه فرض محسوب می‌شود.

بالینی — پزشک مسئول

تأیید نسخه پرسش‌نامه، گروه سنی/بیماری هدف، جمله‌های هشدار، نحوه حل موارد فوری، حداقل کیفیت برنامه، مدت پاسخ و جانشین غیبت. نام پزشک در مدارک قدیمی به‌عنوان تأیید خودکار این پایلوت استفاده نشده است.

داده و حقوق کاربران — مالک داده

متن نهایی رضایت و حریم خصوصی، مدت نگهداری، محل میزبانی، مجوز دسترسی پشتیبانی، قرارداد اسکن فایل و رویه دریافت/حذف اطلاعات. این PRD جای بررسی حقوقی محل فعالیت را نمی‌گیرد و هیچ حکم قانونی خاصی فرض نشده است.

زیرساخت — کارفرما + فنی

دامنه، میزبان و منطقه داده؛ حساب و قالب پیامک؛ پذیرندگی درگاه؛ اسکن فایل؛ بکاپ و کلیدهای امن؛ مانیتورینگ و کانال رسیدگی. حساب‌های پزشک/کارشناس موجود بودن افراد است، نه آماده بودن دسترسی نرم‌افزار. هیچ رمز یا کلید نباید در گفتگو یا فایل Word نوشته شود.

چک‌لیست تحویل نسخه واقعی

کد و مهاجرت قابل بازتولید؛ قیمت و محتوا مصوب؛ تست‌های نقش و پرداخت؛ آزمون دستگاه واقعی؛ بازیابی بکاپ؛ عملیات بازپرداخت و حقوق داده؛ دستورالعمل پزشک/کارشناس؛ فهرست دعوت اولیه؛ ثبت مسئول هر حادثه؛ امضای تصمیم شروع. تا فراهم شدن این شواهد، حالت واقعی مسدود می‌ماند.

منابع فنی اولیه

زرین‌پال: <https://kavenegar.com/rest.html>؛ پیامک: <https://www.zarinpal.com/docs/paymentGateway/connectToGateway>؛ موبایل: <https://www.w3.org/TR/wcag2mobile-22/>؛ کنترل فایل و دسترسی: OWASP File Upload Cheat Sheet و Authorization Cheat Sheet. این منابع مبنای طراحی‌اند، نه گواهی امنیت یا انطباق این نرم‌افزار.